

ITEM 337 : MALAISE, PERTE DE CONNAISSANCE

Définitions	Malaise	= Plainte subjective : indisposition, gêne trouble, sensation pénible vague d'un trouble des fonctions physiologiques
	Perte de connaissance	= Suspension de conscience de courte durée (quelques secondes/minutes) - Spontanément réversible
	Syncope	= Perte de connaissance brève, de quelques minutes, avec une perte du tonus postural et un retour rapide à l'état de conscience normal → hypoperfusion cérébrale globale et passagère
	Lipothymie	= Durée d'hypoperfusion trop brève pour entraîner une perte de connaissance
	Crise comitiale	= Décharge hypersynchrone de neurone : perte de connaissance si la décharge a lieu dans les 2 hémisphères simultanément - Absence, perte de contact de quelques dizaines de secondes - Crise généralisée tonicoclonique (CGTC) avec perte de connaissance prolongée durant quelques dizaines de minutes (crise (3 minutes) et confusion post-critique)
	Pseudo-crise épileptique	= Caricature de crise d'épilepsie, de plusieurs dizaines de minutes, sans perte de connaissance : d'origine psychique
	→ Diagnostic différentiel selon le lieu de reprise d'une conscience claire : - Syncope : reprise de conscience claire sur les lieux de la perte de connaissance, avant l'arrivée des secours - Crise d'épilepsie généralisée : reprise de conscience progressive dans le camion des secours ou aux urgences	

CRISE COMITIALE

CRISE D'EPILEPSIE GÉNÉRALISÉE TONICOCLONIQUE			
C	Arguments diagnostiques	- Début soudain, sans prodrome - Perte de connaissance prolongé : plusieurs dizaines de minutes (crise, coma puis confusion post-critique) avec reprise de conscience progressive - Séquence en 3 phases : - Tonique : hypertonie en extension des 4 membres, cyanose - Clonique : secousses régulières puis espacées - Résolutive : hypotonie et respiration bruyante	
	Eléments inconstants	- Morsure du bord latérale de langue (pathognomonique) à la phase tonicoclonique - Aura épileptique (prodrome) : crise partielle puis généralisée - Chute traumatique et perte d'urine : sans valeur diagnostique	
PC	- EEG (dans les heures ou 24h suivant ++): ondes lentes résiduelles → un EEG normal n'exclut pas le diagnostic - Non nécessaire si patient épileptique connu ou si diagnostic certain		
TTT	- Pendant la crise : position latérale de sécurité, oxygénothérapie - Au décours de la crise : aucun traitement en urgence, clonazépam (Rivotril®) 1 mg IV si 2^{ème} crise		
	Si malade épileptique connu	Si 1 ^{ère} crise	
	- Rechercher un facteur déclenchant : manque de sommeil, alcoolisation, fièvre, mauvaise observance thérapeutique - Réévaluer le traitement si besoin	- Bilan biologique standard + EEG - Scanner cérébral (ou IRM si accessible) → En urgence si symptômes associés (céphalées, déficit neuro), même si crise circonstancielle (alcoolisation...)	
PSEUDO-CRISE EPILEPTIQUE			
C	- Absence de véritable perte de connaissance (difficile à affirmer) - « Perte de connaissance » très prolongée, avec plusieurs dizaines de minutes de mouvements anormaux - Mouvements des membres anarchiques, corps arc-bouté (opisthotonos), mouvements du bassin, cris - Presque toujours en public (conjoint, parents...) - Contexte biographique (abus sexuels, conflit familial/conjugal, bénéfice 2^{ndr}) et antécédents psychiatriques - Résistance à l'ouverture des yeux - Généralement absence de blessure ou de pertes d'urines		
PC	- Eviter les examens complémentaires itératifs - En cas de pseudo-crisés alternant avec des crises authentiques : vidéo-EEG (avec épreuve de suggestion : hyperpnée, stimulation lumineuse intermittente)		
PEC	- Eviter les actes invasifs (intubation...) - Benzodiazépines à la phase aiguë - Psychothérapie à distance		

AUTRES MALAISES ET PERTES DE CONNAISSANCES

Malaise sans perte de connaissance	Attaque de panique	- Épisodes de plusieurs dizaines de minutes, sans perte de connaissance vraie - Vive anxiété, sensation de mort imminente - Symptômes somatiques : oppression thoracique, « tête vide », palpitations, striction laryngée, sueurs, tremblements, vue brouillée... - Crise de tétanie : hyperventilation, paresthésie des extrémités et péribuccales (parfois latéralisées) et spasme carpopédal (« main d'accoucheur ») - PEC : benzodiazépine IV → soulagement rapide
	Ethylisme aigu	- Agitation, agressivité, somnolence ou coma - Diagnostic facile : haleine, habitude, contexte, alcoolémie → Evoquer systématiquement : hypoglycémie, intoxication médicamenteuse, trauma crânien associé → Une crise d'épilepsie généralisée peut survenir lors d'une alcoolisation aiguë ou un sevrage
	Hypoglycémie	- Jamais syncopale - Malaise hypoglycémique : sensation de faim, sueurs, céphalées, troubles visuels, pouvant régresser spontanément ou évoluer vers une confusion mentale, un trouble de la vigilance (somnolence, obnubilation, coma) et des convulsions épileptiques → Généralement diabétique connu et traité → Dosage systématique immédiat de la glycémie capillaire devant tout malaise atypique/inexpliqué
	AIT vertébro-basilaire	- Peut comporter des sensations de malaise : vertige, déséquilibre, céphalées postérieures, nausées, troubles visuels → jamais de perte de connaissance isolée
Malaise + PC	Traumatisme crânien	- Syncope simple ou convulsivante - Crise d'épilepsie généralisée tonico-clonique possible au décours → En l'absence de contexte de traumatique : possible traumatisme crânien 2nd à une syncope ou une crise d'épilepsie généralisée
	Douleur thoracique	= Forme syncopale d' angor ou d' embolie pulmonaire
Autres (rares)	Crise d'épilepsie partielle complexe	Crise d'épilepsie temporale : dure 2-3 minutes, stéréotypée pour un même malade - Sensation épigastrique ascendante, arrêt d'activité avec rupture du contact, fixité du regard, mouvements de mâchonnement ou de déglutition, activité gestuelle simple (frottement...)
	Ictus amnésique	= Oubli à mesure, de plusieurs heures, avec questions itératives mais comportement adapté
	Narcolepsie-cataplexie	= Brusque accès de sommeil irrésistible, pluriquotidiens - Cataplexie = associés à des chutes par hypotonie